
Covid 19 : encore et toujours des questions..

24 janvier 2021

Le temps passe, et des questions (plus ou moins nouvelles) demeurent. A tel point que les certitudes des pouvoirs publics semblent bien fragiles. Aux questions ouvertes depuis des mois, s'ajoutent désormais de nouvelles interrogations. Or, ce qui frappe, c'est moins l'existence de ces importantes questions, que l'obstination à ne pas en parler ou ne pas les prendre en compte. Et on comprend comment - inmanquablement - les mesures de police reviennent au premier plan sans qu'on en connaisse l'impact sanitaire réel.

Le variant anglais, et les autres...

L'apparition du « variant anglais » semble secouer les autorités de santé. Leur inquiétude tient en deux termes :

1. « Tiens ça mute », et
2. le mutant changerait des paramètres importants (contagiosité, dangerosité).

Bien entendu ces deux thèmes ont depuis un moment des réponses. Oui le Covid19 mute (l'IHU de Marseille chez nous l'explique depuis longtemps, sans être vraiment entendu). Comme d'ailleurs bien d'autres virus... Et on sait désormais (voir : https://youtu.be/yvk60TvXu_8) que ces mutations peuvent modifier ce qu'on pourrait appeler le comportement du virus. Mais on le savait depuis l'été au moins, le virus dit « Marseille 4 », se « comportant différemment du virus « initial » rencontré en France. Il suffit de regarder les courbes de propagation des divers variants.

Or, on apprend que dans notre pays on séquence peu les virus (contrairement à l'Angleterre), ce qui explique sans doute cette difficile prise de conscience « nationale ». Et on connaît mal la séroprévalence de la population au virus et a fortiori selon les variants et les régions. L'Espagne, a contrario, dispose d'informations relatives à la seroprévalence indiquant de très fortes disparités régionales. (voir : <https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/15.12151220163348113.pdf>). On aimerait en avoir autant.

Or le problème, c'est que l'existence de variants nombreux et en nombre croissant, peut remettre en cause le peu de certitudes relatives à l'immunité des infectés ou vaccinés, et les modèles épidémiologiques dont le calage des coefficients dépend ainsi sensiblement des variants des virus. Ce qui fragilise encore plus les fragiles prévisions nationales. On

donc là un problème évident qui peut (ou pas) avoir des conséquences importantes. D'où la question des soins....

Les soins ou le paramètre oublié

Incertitude ou pas, le rôle de la médecine est de soigner les malades « au mieux », en fonction des connaissances acquises.

Or de manière redondante cette question centrale du soin et de la stratégie de soin est négligée, au point de bannir des soins efficaces, ou ne pas inciter à utiliser des médicaments peu onéreux et jouant un rôle prophylactique probable. Le discours consistant à insister sur l'intérêt des tests, puis de l'isolement et du soin précoce, ne rentre pas dans les éléments de langage du Ministère ou de Santé Publique France, bien au contraire, même après le « scandale » de l'article frauduleux du Lancet (sur l'Hydroxychloroquine), et l'évidence de résultats encourageants (<https://c19study.com>), combinés avec l'utilisation d'autres substances bon marché (Azithromycine, Zinc,...). D'autres préconisations émergent et font déjà l'objet d'études favorables comme celle de l'Ivermectine.

Derrière des discussions qui ont vite tourné au vinaigre (et à la diffamation) il y a bien un gros problème : celui de l'absence de stratégie de soins précoces.

Un autre problème lui semble lié : celui de la conviction - partagée trop largement hélas - qu'à maladie nouvelle on doit trouver nécessairement une molécule nouvelle pour la soigner.

Vacciner oui, mais qui et comment ?

Vacciner est légitime, sous les conditions habituelles d'efficacité et de sécurité.

Ce qu'on sait aujourd'hui des vaccins qui sont proposés c'est qu'ils sont efficaces à court terme pour les variants anciens, et sans risque significatif également à court terme. Il reste donc deux questions : celle des nouveaux variants et de l'efficacité et des risques à plus long terme. Ce qui fait penser à un pari, non illégitime, mais un pari quand même.

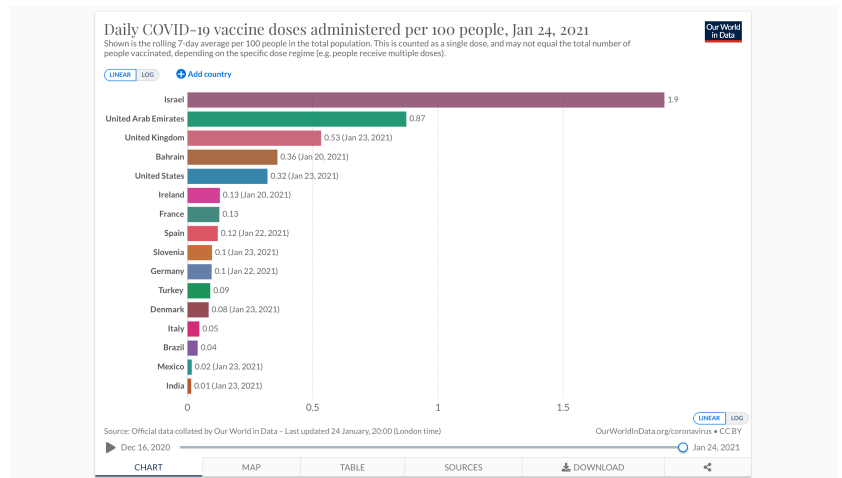
Ensuite il s'agit - ne disposant pas d'un grand stock initial de doses - de savoir qui vacciner et d'organiser la logistique en conséquence (éventuellement complexe compte tenu des contraintes techniques). Deux problèmes distincts donc, mais qui interfèrent nécessairement.

S'agissant de la stratégie vaccinale, le choix des plus fragiles (plus le corps médical), agit sur les facteurs de risques. On aurait pu aussi, légitimement choisir de vacciner d'abord les personnes qui sont les facteurs les plus évidents de contamination. Vieux problème de priorité. Quant à la logistique, on aurait pu, s'en remettre à des logisticiens de métier, dont les réseaux et le savoir-faire permet largement d'intégrer l'ensemble des contraintes. Or,

Or, manifestement, sur ce terrain, on relève actuellement soit un manque de savoir faire, soit des déficiences dans le système d'information.

Donc, en résumé, on a fait un choix (on suppose qu'il a été évalué), mais on peine à réaliser le plan prévu.

Or, la situation dans le monde met en évidence des rythmes différents de vaccination, liés à divers facteurs, l'Union Européenne allant nettement moins vite que d'autres. Pour autant, comme on l'a dit, s'agissant d'un virus émergent et mutant, rien n'assure qu'une stratégie fondée essentiellement sur la vaccination soit très efficace, du moins au regard des expériences historiques.



En outre, les pays qui vaccinent le plus vite seront, à n'en pas douter, scrutés avec grande attention, d'autant que certains (Rapport Israélien) redoutent une mutation accélérée du virus favorisée par une vaccination massive.

De l'incertitude à la décision émotionnelle

De tout ceci il ressort de grandes incertitudes face auxquelles - oubliant largement le soin en ville - les états ont tendance à répondre par des mesures dites de confinement sous diverses formes, et dont on module la nature en fonction des « signes » tirés des indicateurs (cas, positivité, saturation hospitalière, ...).

Or si l'impact théorique de ces mesures est effectif (moins de contacts conduit à moins de contamination), et les mesures de distanciation physique efficaces, l'effet quantitatif des décisions politiques de confinement est difficile à mesurer, d'autant que leur « tempo » est lui même discutable, et que l'on ne tient aucunement compte des formes différents prises par les épisodes dominés par les différents variants du Covid. Il est difficile d'ailleurs de discerner sur les courbes représentatives des variables significatives les marques indiscutables des mesures de confinement. En outre, les indicateurs eux-mêmes ne sont pas homogènes dans le temps.

On risque donc, une fois encore, de s'en remettre à ces seules mesures que l'on maîtrise à peu près - puisque ce sont des mesures de police - tout en faisant comme si le miracle du vaccin allait opérer. L'émotion (la peur) poussée par la crainte de voir les hôpitaux saturés, conduirait donc à la seule décision possible faute de stratégie médicale.